

קבוצה	מרחיב סמכונות פְּרֶה־סימפטוליטי
מנגנון הפעולה	אנטי־כולינרגי, אנטגוניסט לרצפטור המוסקריני. קרוב בהרכבו הכימי לאטרופין ופועל בצורה דומה. בשל חסימת הרצפטור המוסקריני בשרירים החלקים שבדופנות דרכי הנשימה – קיימת ירידה בייצור של CGMP. ירידה זו משפיעה ישירות על יכולת השריר החלק להתכווץ ועל יכולת האפיתל להפריש נוזלים, וכך למעשה מושג האפקט של הרחבת דרכי הנשימה והפחתה בהפרשות. במתן באינהלציה אירובנט אינו נספג למערכת הדם ועל כן אינו משפיע בצורה מערכתית. נוסף על כך מבנהו הכימי אינו מאפשר לו לחדור את ה־B.B.B ולכן גם אינו משפיע על ה־CNS.
פרמקוקינטיקה	10% מהמנה הנשאפת מגיע לדרכי האוויר התחתונות, 0.5% מתפזר במערכת. שיא ההשפעה לאחר 1.5–2 שעות. משך ההשפעה 4–6 שעות. זמן מחצית חיים הוא 1.5–2 שעות.
התוויות לשימוש	בדרך כלל אפשר לשלב עם ונטולין; מחלות דרכי נשימה חסימתיות, כגון COPD ואסתמה; היצרות בדרכי הנשימה; הרעלת זרחנים אורגניים.
התוויות נגד	רגישות יתר לתרופה; גלאוקומה (מסוג narrow angle).
תופעות לוואי	יובש בפה; כאבי ראש; שיעול; ייבוש הפרשות.
מינון	מבוגרים וילדים מעל 20 ק"ג – 0.5 mg, מתן ב־Inh. מקסימום של 3 מנות (בהתקף קשה). תינוקות וילדים מתחת ל־20 ק"ג – 0.25 mg, מתן ב־Inh. מקסימום של 3 מנות (בהתקף קשה). בהרעלת זרחנים אורגניים – מינון כפול.
צורות מתן במד"א	Inhalation
מופיע בפרוטוקול	<u>התקף אסתמה במבוגר; התקף אסתמה בילדים; החמרה במחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD); תגובה אלרגית (אנפילקסיס) מבוגר; הטיפול בנפגע עם חשד להרעלת זרחנים אורגניים</u>

